

这两天，41岁的网红张雪峰的突然离世，让很多跑者心里一紧。作为一名医生，也是一名长期跑步的人，我想和身边的朋友说几句理性、重要的话。

1 跑步不是死因，真正的风险是“猝死”

首先要明确一点：
跑步本身并不是导致死亡的原因。

绝大多数类似事件，本质上属于
👉 心源性猝死（心源性休克）
也就是心脏在短时间内发生严重电活动紊乱（如室颤），导致泵血功能突然停止。

⚠️ 关键点：
这种情况可以发生在任何人群；
不仅限于跑者，也见于普通人、甚至年轻人；
运动只是一个“诱因”，而不是根本原因

👉 所以：
不要因为个案而恐惧运动，更不要因此停止跑步。

✓ 跑步依然是目前证据最充分的“延寿运动”之一
✓ 对心血管、代谢、情绪都有明确益处

2 但跑者并非“免疫”：不要高估自己

我们必须承认一个现实：
👉 跑者 ≠ 不会猝死的人

即使是长期运动者，也可能存在：
潜在的冠心病（尤其30岁以上）
心肌病（肥厚型、扩张型等）
心律失常基础问题

而以下情况，会明显增加风险：
！ 过度疲劳（连续高强度训练）
！ 睡眠不足
！ 生病仍坚持跑（尤其发烧、病毒感染）
！ 突然增加训练强度（“报复性跑步”）
！ 长时间比赛或极限挑战

👉 很多猝死事件，并不是“跑太多”，而是：
“在不该拼的时候拼了”

3 跑者必须知道的“猝死前信号”

心源性猝死往往并非完全无征兆，常见“预警”包括：
⚠️ 运动中或运动后出现：
胸闷、胸痛
明显气短（不成比例）
心悸、心跳紊乱
头晕、眼前发黑
突然乏力

👉 原则只有一个：
一旦出现，立刻停止运动，不要硬撑！

4 给跑者的几个重要建议

- ✓ 1. 做一次基础心脏评估（尤其40岁以上）
心电图
必要时心脏彩超 / 运动试验
 - ✓ 2. 遵循“渐进原则”
每周跑量增加不超过10%
避免突然上强度
 - ✓ 3. 学会“听身体的话”
累 ≠ 可以硬扛
不舒服时，休息比坚持更重要
 - ✓ 4. 生病时不要跑
特别是发烧、病毒感染期
👉 这类状态最容易诱发心肌炎 → 猝死风险上升
 - ✓ 5. 不要一个人做极限挑战
长距离、越野、极端天气
👉 尽量结伴或有保障
 - ✓ 6. 了解急救知识
心肺复苏（CPR）
自动体外除颤器（AED）
- 👉 很多猝死，是“可以被救回来的”

5 最重要的一句话

我们纪念一位跑者，不是因为害怕跑步，而是应该更科学地跑下去...
👉 跑步不会害人
👉 忽视身体、盲目挑战极限，才可能带来风险

愿我们共勉：敬畏生命，理性运动，长久而健康地跑下去。

橄榄树健康咨询感谢您的关注及分享